SDD 126 Sujet n°1

Spécialité : Neurologie

Date : 27/10/2024
Auteur : Gaëlle Tisserand - DES MPR 2024
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Examen clinique
Item(s) en lien avec la station	107. Mouvements anormaux 106. Maladie de Parkinson
Situation(s) de départ en lien avec la station	126. Mouvements anormaux 128. Tremblements
Matériel nécessaire à la station	3 chaises - 1 table - papier de brouillon - stylos - iPad pour examinateurs
Contexte de la station	Interrogatoire et examen clinique d'un tremblement essentiel

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste.
Vous recevez Mme Morvan, âgée de 42 ans au cabinet qui présente des mouvements anormaux.

Consignes :
Vous devez réaliser en 8 minutes :

- Réaliser un interrogatoire orienté sur les symptômes
- Citer **une** manœuvre pour mettre en évidence les mouvements de la patiente et la réaliser
- Evoquer une hypothèse diagnostique

Vous ne devez pas :

- Réaliser d'examen clinique complet
- Prescrire d'examen complémentaire
- Proposer de prise en charge

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
1.	L'étudiant fait préciser s'il s'agit d'un tremblement de repos ou d'un tremblement d'action	1 point
2.	Se renseigne sur la localisation du tremblement : bilatéral ET/OU symétrique	1 point
3.	Demande si le tremblement touche le chef et/ou la voix	1 point
4.	Demande la date d'apparition des symptômes	1 point
5.	Demande le mode d'apparition (brutal ou progressif)	1 point
6.	L'étudiant recherche une origine iatrogène en demandant si la patiente prend des traitements et précise au moins une des classes médicamenteuses suivantes : Antinauséeux (Métoclopramide) - Inhibiteur calcique - Antihistaminique - Antiangineux - Thymorégulateur (Lithium) – Antiarythmique (Amiodarone) - Antiépileptique (Valproate) *Point seulement si cite un exemple de classe médicamenteuse/médicament*	1 point
7.	Se renseigne sur l'existence d'antécédents familiaux de tremblements *(pas de point si demande les antécédents généraux)*	1 point
8.	Cherche des facteurs aggravants : Tremblement aggravé par le stress/la fatigue/les émotions et/ou la caféine	1 point
9.	Cherche des facteurs améliorants : Tremblement amélioré par la prise d'alcool et/ou les benzodiazépines	1 point
10.	Evalue le retentissement sur la vie quotidienne (difficulté à cuisiner/manger, se maquiller, au travail…)	1 point
11.	Recherche une gêne psycho-sociale (regard des autres, n'ose plus sortir avec ses amis etc)	1 point
12.	Cite et réalise une des manœuvres suivantes : manœuvre des bras tendus appelée aussi manœuvre du serment (maintient une posture comme tendre les mains devant lui) - manœuvre du bretteur (rapprocher ses index à l'horizontale) - épreuve des verres (verser de l'eau d'un verre à l'autre) – demande au patient de tenir une note à voix haute (tremblement de la voix) – demande au patient d'écrire ou de reproduire une spirale	1 point
13.	Evoque le diagnostic de tremblement essentiel	1 point

Communications et attitudes

14.

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

15.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise de différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant le plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

16.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

17.	**1. Échelle d'évaluation de performance globale: description générale**

Performance Insuffisante *Clear fail*	**Performance Limite** *Borderline*	**Performance Satisfaisante** *Clear pass*	**Performance Très Satisfaisante** *Very good pass*	**Performance Remarquable** *Excellent pass*
Très au-dessous des attentes	Performance proche mais en dessous des attentes	**Conforme aux attentes**	**Au-delà des attentes**	**Très au-delà des attentes**
Les attentes sont non observables ou non respectées Présente un niveau inacceptable de connaissances ou de performance	Les omissions et les inexactitudes dans la réalisation des tâches Démontre du potentiel pour atteindre la compétence	Démontre les éléments essentiels de la performance Prêt pour avancer en toute sécurité	Quelques omissions/erreurs mineures et non essentielles Démontre la plupart des aspects de la compétence	Agit sans hésitation et sans erreur Démontre la maîtrise de tous les aspects de la compétence

TOTAL	**…/17 points**

Bonus : Vidéo du CEN sur l'interrogatoire d'un patient avec tremblements essentiel : https://www.cen-neurologie.fr/videotheque/tremblement-essentiel

Éléments de rétroaction :

Aux ECOS une station interrogatoire = on donne tout sur l'interrogatoire ! Même si on arrive très rapidement à la conclusion, les grilles demandent souvent le plus d'éléments possibles alors il ne faut pas hésiter à être exhaustif.
Pour briller aux ECOS, penser à l'étape d'après qui est le retentissement sur la vie du patient est vraiment un plus : cela montre à l'examinateur que vous allez plus loin que juste poser un diagnostic mais que vous vous intéressez vraiment au bien-être du patient. Cela sera notamment valorisé dans les échelles d'attitude.

Pour la partie théorique :
Ici la patiente présentait un tremblement d'action, c'est-à-dire qu'il est présent lors du maintien d'une posture (tremblement postural) et/ou de l'arrivée à la cible (tremblement intentionnel).
• La cause la plus fréquente de tremblement postural est le tremblement essentiel.
• Le tremblement cérébelleux est un tremblement surtout intentionnel.
• Le tremblement essentiel en est la cause la plus fréquente. Il s'agit d'un tremblement d'action, à la fois postural et intentionnel qui évolue lentement sur plusieurs années, parfois plusieurs décennies. Il est mis en évidence lorsque le patient écrit, reproduit une spirale, maintient une posture comme tendre les mains devant lui (manœuvre des bras tendus appelée aussi manœuvre du serment)

ou rapprocher ses index à l'horizontale (manœuvre du bretteur), fait une action comme verser de l'eau d'un verre à l'autre (épreuve des verres) ou tient une note à voix haute (tremblement de la voix). Il peut être handicapant dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne (comme manger) et peut provoquer une gêne psychosociale.

• Le tremblement essentiel est habituellement bilatéral et symétrique, d'une fréquence de 6 à 12 Hz, touchant les membres supérieurs, le chef, la voix et les membres inférieurs. Il est volontiers amélioré par la prise d'alcool mais aggravé par les émotions et la caféine. Il existe souvent des antécédents familiaux de tremblement d'action.

• En cas de doute entre un tremblement lié à la maladie de Parkinson et un tremblement essentiel, un DaTSCAN®peut être effectué (il est normal dans le tremblement essentiel), afin d'aider au diagnostic et de commencer un traitement adapté. L'IRM cérébrale est normale dans le tremblement essentiel et ne doit pas être pratiquée quand le tableau est typique.

• Les traitements les plus efficaces, à débuter s'il existe un retentissement fonctionnel et/ou une gêne psychosociale sont le bêtabloquant propranolol(Avlocardyl®, de 40 à 160 mg par jour) et le barbiturique primidone(Mysoline®, de 50 à plus de 500 mg par jour), l'antiépileptique topiramate (Epitomax®) et la benzodiazépine alprazolam (Xanax®). Dans les formes sévères pour lesquelles le traitement est inefficace ou non toléré, un traitement chirurgical par stimulation électrique chronique à haute fréquence du noyau intermédioventral (Vim) au niveau du thalamus peut être proposé, voire une thalamotomie par gamma knife.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste.
Vous recevez Mme Morvan, âgée de 42 ans au cabinet qui présente des mouvements anormaux.

Consignes :
Vous devez réaliser en 8 minutes :

- Réaliser un interrogatoire orienté sur les symptômes
- Citer **une** manœuvre pour mettre en évidence les mouvements de la patiente et la réaliser
- Evoquer une hypothèse diagnostique

Plan de la station ECOS :

Le patient est assis face au candidat, séparé par une table.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour docteur, je viens vous voir à cause de mes tremblements.

Identité du patient :

Mme Morvan Justine, 42 ans, 1m68, 63kg, IMC 22.3

Mode de vie :

Avocate, 2 enfants, loisirs : randonnée, pas de tabac, pas d'alcool, pas d'allergie

Comportement global :

Thymie neutre, attentive aux explications.
Pas de tremblement au repos à mimer /!\

Antécédents personnels :

Pas d'antécédent particulier

Antécédents familiaux :

Tremblements chez sa mère : Ne PAS le dire si l'étudiant demande les antécédents familiaux généraux. « Est-ce que quelqu'un dans la famille a des tremblements aussi ? » -> là OUI « oui, ma mère »
Pas de tremblement

Médicaments :

Pas de traitement mais si l'étudiant vous demande "prenez vous des médicaments", demandez lesquels il recherche avant de répondre

Symptômes positifs :

Vous vous plaignez de tremblements, mais il faut être laconique pour ne pas faire perdre de points à l'étudiant :

Si l'étudiant demande où ? -> aux bras

Quel bras ? -> les deux

Est-ce que vous tremblez de la tête/du menton/tremblement de la voix ? -> Ca m'est arrivé dans le passé, mais plus maintenant

Est-ce que c'est symétrique ? -> oui

Quand ? -> Tout le temps, dès que j'essaie de faire quelque chose, c'est très pénible. Pas de tremblement quand je dors.

Depuis quand ? -> Depuis toujours j'ai l'impression

Est-ce que ça s'est aggravé ? -> Je crois que ça s'aggrave progressivement donc je saurais pas vous dire une date précise

Est-ce que votre tremblement est aggravé par le stress/la fatigue/les émotions/la caféine ? -> Oui

Est-ce que vous avez remarqué si vos tremblements diminuent par la prise d'alcool/les benzodiazépines ? -> Oui

Est-ce que votre tremblement augmente au moment d'atteindre sa cible ou quand vous vous concentrez (ex : calcul mental) ? -> NON

Tout autre facteur aggravant ou calmant : répondre non, et pas d'autre symptôme associé (pas de syndrome extra-pyramidal à type de rigidité/akinésie, pas de trouble de la marche)

Est-ce que vous êtes gênée dans la vie quotidienne ? -> Au travail je m'en sors avec mon ordinateur, mais à la maison j'ai du mal à cuisiner et je me coupe assez souvent.

Est-ce que vous êtes gênée par le regard des autres ou vous avez renoncé à des sorties avec vos amis ? -> Non heureusement, je tremble depuis toujours ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'aller au restaurant avec mes amis.

L'étudiant va vous demander de réaliser une manœuvre. Pour rappel, au repos vous ne tremblez pas. Il vous demandera de tenir une posture, quelle que soit la posture vous devez trembler en la tenant :
https://www.cen-neurologie.fr/videotheque/tremblement-dattitude-daction

Questions de relance :

Essayer de ramener le patient sur l'interrogatoire le plus possible :
« Comment vous savez ce que j'ai ? » « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? »

S'il a annoncé le diagnostic de tremblement essentiel trop vite et que la station est finie trop rapidement : « Quelles sont les caractéristiques de ce tremblement essentiel dont vous parlez ? »

Si le patient évoque une maladie de Parkinson « je ne suis pas un peu jeune pour avoir cette maladie ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Le patient est face à l'étudiant·e, un bureau séparant les deux personnes.

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*